Health Assessment
تقييم صحي

LECTURE 4 · المحاضرة 4

تقييم الرئتين والصدر — بنك الأسئلة
Lung and Thorax Assessment — Exam & Questions

المرحلة الثانية

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حسن علي

LEC 4

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Preparation and inspection — التحضير والفحص بالنظر

Q1 EN **For a female client, the gown is:**

AR س1. بالنسبة للأنثى يكون الرداء:

A. Removed completely — منزوعًا بالكامل
B. Left on & open at the back — متروكًا عليها ومفتوحًا من الخلف
C. Open at the front — مفتوحًا من الأمام
D. Not used — غير مستعمل

Q2 EN **The normal respiratory rate in the lecture is:**

AR س2. معدّل التنفّس الطبيعي في المحاضرة:

A. 12-20/min — د/12-20
B. 8-10/min — د/8-10
C. 20-30/min — د/20-30
D. 30-40/min — د/30-40

Q3 EN **The normal anterior-posterior to lateral diameter ratio is:**

AR س3. النسبة الطبيعية للقطر الأمامي الخلفي إلى الجانبي:

A. 1:1
B. 2:1
C. 1:2
D. 1:3

Q4 EN **The normal rib slope is:**

AR س4. ميل الأضلاع الطبيعي:

A. More than 90 degrees upward — أكثر من 90 درجة للأعلى
B. Horizontal — أفقي
C. Exactly 90 degrees — 90 درجة تمامًا
D. Less than 90 degrees downward — أقل من 90 درجة للأسفل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal sternum is:** Q5

AR س5. القصّ الطبيعي:

A Protruding بارز
B Depressed منخفض
C Level with ribs بمستوى الأضلاع
D Deviated منحرف

Palpation الجسّ

EN **Vocal fremitus is assessed while the client says:** Q6

AR س6. يُقيِّم الرجفان الصوتي بينما يقول المريض:

A 99
B Ahh آه
C Ee إي
D 1-2-3

EN **Normal vocal fremitus is:** Q7

AR س7. الرجفان الصوتي الطبيعي:

A Equal everywhere متساوٍ في كل مكان
B Increased at the periphery يزداد في المحيط
C Absent غائب
D Decreased at the periphery, increased over major airways
يقلّ في المحيط ويزداد فوق المجاري الرئيسة

EN **During fremitus palpation, avoid palpating over the:** Q8

AR س8. عند جسّ الرجفان تجنّب الجسّ فوق:

A Apices القمّتين
B Scapulae لوحي الكتف
C Trachea الرغامى
D Interspaces المسافات الوربية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For posterior thoracic expansion, the thumbs are placed at the level of:** Q9

AR س9. لتقييم التمدّد الخلفي يوضع الإبهامان بمستوى:

A T1 to T2 — T1 إلى T2
B T9 to T10 — T9 إلى T10
C L1 to L2 — L1 إلى L2
D C7

EN **For anterior thoracic expansion, the thumbs point toward the:** Q10

AR س10. لتقييم التمدّد الأمامي يتّجه الإبهامان نحو:

A Clavicles — الترقوتين
B Umbilicus — السُّرّة
C Axilla — الإبط
D Xiphoid process — الناتئ الرهابي

EN **Normal thoracic expansion is:** Q11

AR س11. التمدّد الصدري الطبيعي:

A 2 to 3 inch symmetrical — 2 إلى 3 بوصة ومتناظر
B 1 inch — بوصة واحدة
C Asymmetrical — غير متناظر
D 5 inch — 5 بوصات

Percussion — القرع

EN **Which sound predominates in healthy lung tissue?** Q12

AR س12. أي صوت يسود في نسيج الرئة السليم؟

A Dullness — الأصمّية
B Flatness — الصوت المسطّح
C Resonance — الرنين
D Tympany — الطبلي

EN **Cardiac dullness is normally found on the:** Q13

AR س13. توجد الأصمّية القلبية طبيعياً في:

A Posterior chest — الصدر الخلفي
B Anterior chest — الصدر الأمامي
C Lung apices — قمّتي الرئتين
D Scapulae — لوحي الكتف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Percussion of the lung fields is done in the:** Q14

AR س14. يُجرى قرع الحقول الرئوية في:

A	Ribs الأضلاع	B	Breast الثدي
C	Scapulae لوحي الكتف	D	Interspaces المسافات الوربية

EN **Diaphragmatic excursion is percussed down the:** Q15

AR س15. تُقرع حركة الحجاب الحاجز نزولًا على:

A	Midsternal line خط منتصف القصّ	B	Midaxillary line الخط الإبطي المتوسط
C	Scapular line خط الكتف	D	Midclavicular line خط منتصف الترقوة

EN **Normal diaphragmatic excursion in adults is about:** Q16

AR س16. حركة الحجاب الطبيعية عند البالغ نحو:

A	3-5 cm 3-5 سم	B	10-12 cm 10-12 سم
C	0.5 cm 0.5 سم	D	1 cm 1 سم

EN **Diaphragmatic excursion may normally be up to:** Q17

AR س17. قد تصل حركة الحجاب طبيعيًا إلى:

A	15 cm 15 سم	B	12 cm 12 سم
C	7-8 cm 7-8 سم	D	2 cm 2 سم

Auscultation الإصغاء

EN **Lung auscultation is done with the:** Q18

AR س18. يُجرى إصغاء الرئة بـ:

A	Bell lightly applied الجرس بلطف	B	Diaphragm held firmly الغشاء بإحكام
C	Palm of the hand راحة اليد	D	Ulnar edge الحافة الزندية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The most important point in lung auscultation is:** Q19

AR س19. أهم نقطة في إصغاء الرئة:

A Listening fast — الاستماع بسرعة
B Using the bell — استعمال الجرس
C Shallow breathing — التنفّس السطحي
D Side to side comparison — المقارنة جانبًا بجانب

EN **Bronchial breath sounds are heard over the:** Q20

AR س20. تُسمع أصوات التنفّس القصبية فوق:

A Trachea — الرغامى
B Main stem bronchi — القصبتين الرئيستين
C Diaphragm — الحجاب الحاجز
D Lung periphery — محيط الرئة

EN **In bronchovesicular sounds:** Q21

AR س21. في الأصوات القصبية الحويصلية:

A Inspiration equals expiration — الشهيق يساوي الزفير
B Expiration is longer — الزفير أطول
C Inspiration is longer — الشهيق أطول
D No expiration — لا زفير

EN **Vesicular sounds are:** Q22

AR س22. الأصوات الحويصلية:

A Loud, over trachea — عالية فوق الرغامى
B Low, soft, over lung periphery; inspiration longer than expiration — منخفضة ناعمة فوق المحيط؛ الشهيق أطول من الزفير
C Heard between scapulae; I = E — بين لوحي الكتف؛ الشهيق = الزفير
D Absent normally — غائبة طبيعيًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

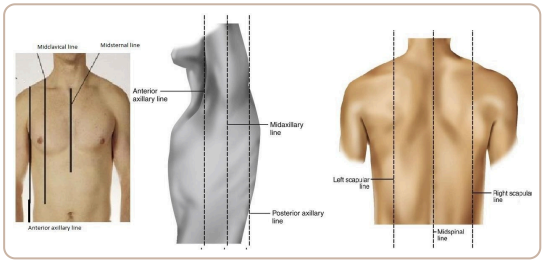
EN **Anterior auscultation extends from the apices down to the:** Q23

AR س23. يمتد الإصغاء الأمامي من القمّتين نزولًا إلى:

A Second rib — الضلع الثاني
B Fourth rib — الضلع الرابع
C Sixth rib — الضلع السادس
D Tenth rib — الضلع العاشر

EN **Picture: this figure shows:** Q24

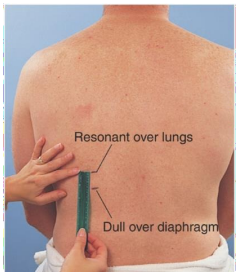
AR س24. صورة: يوضّح هذا الشكل:



A Lung lobes — فصوص الرئة
B Auscultation sites — مواقع الإصغاء
C Heart areas — مناطق القلب
D Respiratory landmarks (imaginary lines) — المعالم التنفّسية (الخطوط الوهمية)

EN **Picture: the examiner is assessing:** Q25

AR س25. صورة: الفاحص يقيّم:



A Tracheal position — موضع الرغامى
B Vocal fremitus — الرجفان الصوتي
C Thoracic expansion — التمدّد الصدري
D Diaphragmatic excursion — حركة الحجاب الحاجز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN The male client uncovers to the waist.

AR يكشف المريض الذكر جسمه حتى الخصر.

True · صح False · خطأ

2 EN Normal intercostal spaces are retracted.

AR المسافات الوربية الطبيعية منسحبة.

True · صح False · خطأ

3 EN The trachea is normally in the midline.

AR الرغامى طبيعيًا في خط الوسط.

True · صح False · خطأ

4 EN Vocal fremitus increases at the periphery of the lungs.

AR يزداد الرجفان الصوتي في محيط الرئتين.

True · صح False · خطأ

5 EN Fremitus can be palpated with the ulnar edge of one hand.

AR يمكن جسّ الرجفان بالحافة الزندية ليد واحدة.

True · صح False · خطأ

6 EN Percussion is done directly over the female breast.

AR يُجرى القرع مباشرةً فوق ثدي الأنثى.

True · صح False · خطأ

7 EN Diaphragmatic excursion should be equal bilaterally.

AR يجب أن تكون حركة الحجاب متساوية في الجانبين.

True · صح False · خطأ

8 EN The client breathes through the nose during lung auscultation.

AR يتنفّس المريض من الأنف أثناء إصغاء الرئة.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN Listen to at least one full respiration in each location.

AR استمع إلى دورة تنفّس كاملة واحدة على الأقل في كل موضع.

True · صح False · خطأ

10 EN In bronchial sounds, expiration is longer than inspiration.

AR في الأصوات القصبية الزفير أطول من الشهيق.

True · صح False · خطأ

11 EN Bronchovesicular sounds are heard over the lung periphery.

AR تُسمع الأصوات القصبية الحويصلية فوق محيط الرئة.

True · صح False · خطأ

12 EN Posterior auscultation is done with the client leaning forward slightly.

AR يُجرى الإصغاء الخلفي والمريض مائل للأمام قليلًا.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Bronchial vs bronchovesicular vs vesicular

AR القصبي مقابل القصبي الحويصلي مقابل الحويصلي

2 EN Fremitus: periphery vs airways

AR الرجفان: المحيط مقابل المجاري

3 EN Posterior vs anterior expansion

AR التمدّد الخلفي مقابل الأمامي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Resonance vs dullness 4

AR الرنين مقابل الأصمّية

EN Diaphragm or bell for the lungs? 5

AR الغشاء أم الجرس للرئتين؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the normal findings of thorax inspection. 1

AR عدّد النتائج الطبيعية لفحص الصدر بالنظر.

EN How is vocal fremitus assessed? 2

AR كيف يُقيَّم الرجفان الصوتي؟

EN Describe the measurement of diaphragmatic excursion. 3

AR صف قياس حركة الحجاب الحاجز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare the three normal breath sounds. 4

AR قارن بين أصوات التنفّس الطبيعية الثلاثة.

EN Give the steps of posterior auscultation of the thorax. 5

AR اذكر خطوات الإصغاء الخلفي للصدر.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 C	4 D	5 C	6 A	7 D	8 B
9 B	10 D	11 A	12 C	13 B	14 D	15 C	16 A
17 C	18 B	19 D	20 A	21 A	22 B	23 C	24 D
25 D							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 EN **Bronchial vs bronchovesicular vs vesicular**

Bronchial: over trachea, loud, E > I. Bronchovesicular: over main stem bronchi, below clavicles and between scapulae, I = E. Vesicular: periphery, low and soft, I > E.

AR **القصبي مقابل القصبي الحويصلي مقابل الحويصلي**

القصبي: فوق الرغامى، عالٍ، الزفير > الشهيق. القصبي الحويصلي: فوق القصبتين الرئيستين، تحت الترقوتين وبين لوحي الكتف، الشهيق = الزفير. الحويصلي: المحيط، منخفض وناعم، الشهيق > الزفير.

2 EN **Fremitus: periphery vs airways**

Vibration decreases over the periphery and increases over the major airways.

AR **الرجفان: المحيط مقابل المجاري**

يقلّ الاهتزاز فوق المحيط ويزداد فوق المجاري الرئيسة.

3 EN **Posterior vs anterior expansion**

Posterior: thumbs at T9 to T10. Anterior: thumbs along the costal margins pointing toward the xiphoid process.

AR **التمدّد الخلفي مقابل الأمامي**

الخلفي: الإبهامان عند T9 إلى T10. الأمامي: الإبهامان على الحافتين الضلعيتين باتجاه الناتئ الرهابي.

4 EN **Resonance vs dullness**

Resonance predominates in healthy lung; cardiac dullness is normal on the anterior chest and over the diaphragm.

AR **الرنين مقابل الأصمّية**

يسود الرنين في الرئة السليمة؛ والأصمّية طبيعية فوق القلب في الصدر الأمامي وفوق الحجاب.

5 EN **Diaphragm or bell for the lungs?**

The diaphragm of the stethoscope, held firmly on the chest wall.

AR **الغشاء أم الجرس للرئتين؟**

غشاء السمّاعة، مثبّتًا بإحكام على جدار الصدر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the normal findings of thorax inspection.**

Color pink; intercostal spaces even & relaxed; chest symmetry equal; rib slope less than 90 degrees downward; respiration even 12-20/min, unlabored; AP to lateral diameter 1:2; sternum level with ribs; trachea midline.

AR **عدّد النتائج الطبيعية لفحص الصدر بالنظر.**

اللون وردي؛ والمسافات الوربية منتظمة ومرتخية؛ والصدر متناظر؛ وميل الأضلاع أقل من 90 درجة للأسفل؛ والتنفّس منتظم 12-20/د بلا جهد؛ والقطر الأمامي الخلفي إلى الجانبي 1:2؛ والقصّ بمستوى الأضلاع؛ والرغامى في الوسط.

2

EN **How is vocal fremitus assessed?**

Use the palm base (ball) of the fingers or the ulnar edge of one hand; touch the chest; ask the client to repeat 99; start over the apices and palpate side to side; avoid the scapulae. Normal: vibration decreases over the periphery and increases over major airways.

AR **كيف يُقيَّم الرجفان الصوتي؟**

تُستعمل قاعدة الراحة أو الحافة الزندية؛ ويُلمس الصدر؛ ويكرّر المريض 99؛ ويُبدأ من القمّتين جانبًا بجانب؛ وتُتجنّب لوحا الكتف. الطبيعي: يقلّ الاهتزاز في المحيط ويزداد فوق المجاري الرئيسة.

3

EN **Describe the measurement of diaphragmatic excursion.**

The client exhales and holds; percuss down the scapular line until resonance changes to dullness and mark it; the client takes a deep breath and holds; percuss down from the mark and mark the new level; measure the difference. Normal: equal bilaterally, about 3-5 cm in adults, may be up to 7-8 cm.

AR **صف قياس حركة الحجاب الحاجز.**

يزفر المريض ويحبس؛ ويُقرع نزولًا على خط الكتف حتى يتغيّر الرنين إلى أصمّية ويُعلَّم؛ ثم يأخذ نفسًا عميقًا ويحبسه؛ ويُقرع من العلامة نزولًا ويُعلَّم المستوى الجديد؛ ويُقاس الفرق. الطبيعي: متساوٍ في الجانبين ونحو 3-5 سم وقد يصل 7-8 سم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare the three normal breath sounds.** 4

Bronchial: over trachea, loud, expiration longer than inspiration, short silence between them. Bronchovesicular: over main stem bronchi, below clavicles and between scapulae, inspiration equal to expiration. Vesicular: low, soft, over lung periphery, inspiration longer than expiration.

AR **قارن بين أصوات التنفّس الطبيعية الثلاثة.**

القصبي: فوق الرغامى، عالٍ، والزفير أطول مع صمت قصير بينهما. القصبي الحويصلي: فوق القصبتين الرئيستين، تحت الترقوتين وبين لوحي الكتف، والشهيق = الزفير. الحويصلي: منخفض ناعم فوق المحيط، والشهيق أطول.

EN **Give the steps of posterior auscultation of the thorax.** 5

Client sitting, leaning forward slightly with arms resting; breathe through the mouth, deeper than usual; monitor breathing; use the diaphragm held firmly on the chest wall; listen to at least one full respiration in each location; compare side to side; do not confuse background noise with lung sounds.

AR **اذكر خطوات الإصغاء الخلفي للصدر.**

يجلس المريض مائلًا للأمام وذراعاه مستريحتان؛ ويتنفّس من الفم أعمق من المعتاد؛ ويُراقب التنفّس؛ ويُستعمل الغشاء بإحكام؛ ويُستمع لدورة تنفّس كاملة على الأقل في كل موضع؛ وتُقارن الجهتان؛ ولا تُخلط ضوضاء الخلفية بأصوات الرئة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t